

Hierarchia *interwencji*

Kontinuum od interwencji wspierających po ekspresyjne. Im wyżej, tym więcej wymaga siły ego, sojuszu i dojrzałości fazy. Interpretacja jest nagrodą, nie standardem.

CZAS: 25 min Planowanie interwencji; superwizja; formulacja **ŹRÓDŁO:** Gabbard (2014); Cabaniss (2017)

JAK UŻYWAĆ

Dobierasz interwencję do gotowości pacjenta, poruszając się po kontinuum od **wspierających** (psychoedukacja, empatia, walidacja, klaryfikacja) po **ekspresyjne** (konfrontacja, interpretacja obrony, interpretacja przeniesienia, interpretacja łącząca z historią życia). Zaczynasz nisko, budujesz sojusz, przechodzisz wyżej tylko gdy pacjent ma dostępny afekt i wątek jest gotowy. Po każdej interwencji obserwujesz: pacjent idzie głębiej czy się zamyka?

DLACZEGO TO DZIAŁA

Interpretacja bez przygotowania „trafia w pustkę”; sama ciepła obecność bez interpretacji nie daje wglądu. Każdy poziom buduje na poprzednim — bez wsparcia nie ma bezpieczeństwa do interpretacji, bez interpretacji nie ma wglądu. Dla słabszego ego przeważają interwencje wspierające; dla silniejszego dostępne jest pełniejsze spektrum. Najczęstsze błędy: interpretować zbyt szybko, by „pokazać wgląd” (terapia staje się pouczeniem), albo utknąć w ciepłym wsparciu bez pracy — STPP wymaga też konfrontacji i interpretacji.

01 Kontinuum: wspierające → ekspresyjne

- ① **Wsparcie** — empatia, uznanie, walidacja, normalizacja
- ② **Klaryfikacja** — „jeśli dobrze rozumiem, czuje Pani...”
- ③ **Konfrontacja** — „zauważam, że za każdym razem, gdy...”
- ④ **Interpretacja obrony** — „intelektualizuje Pani, żeby nie czuć”
- ⑤ **Interpretacja przeniesienia** — wzorzec w relacji ze mną
- ⑥ **Interpretacja łącząca** — wzorzec połączony z historią życia

02 Oceń gotowość pacjenta dziś

Czy pacjent jest zdolny do głębokiej pracy, czy potrzebuje wsparcia i stabilizacji? Zaczynij od niższych poziomów — budują sojusz.

GOTOWOŚĆ PACJENTA I POZIOM STARTOWY

03 ☉ Obserwuj reakcję, dostosuj poziom

Po każdej interwencji sprawdź: pacjent idzie głębiej (afekt, skojarzenia, wgląd) czy się zamyka (milczenie, intelektualizacja, wycofanie)? Jeśli się zamyka — cofnij się do niższego poziomu; interwencja była zbyt ambitna.

REAKCJA NA INTERWENCJĘ I KOREKTA

04 ✨ Sprawdź własną tendencję

Większość terapeutów ma tendencję do jednego poziomu (zwykle wsparcia albo intelektualnej interpretacji). Zapisz, do którego ciążniesz, i który warto świadomie ćwiczyć.

MOJA TENDENCJA → POZIOM DO ROZWIJANIA

Klucz: interpretacja jest nagrodą, nie standardem — robisz ją rzadko, gdy materiał jest oczywisty; najczęściej pracujesz niżej na kontinuum. Nagrywaj sesje (za zgodą) i analizuj w supervizji: z którego poziomu była interwencja i jaka była reakcja? To uczy precyzji.